ONEMA-POP-007 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA SAÚDE | POP-007

Manejo Seguro de Suspeita de Obstrução de Sonda Nasoenteral ou

Gastrostomia

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação de perda de permeabilidade de dispositivos enterais no domicílio e tentativa conservadora, quando

permitida pelo tipo de sonda e protocolo do serviço responsável. Não abrange troca de sonda, confirmação de posição por

métodos não validados ou uso de agentes químicos de desobstrução sem prescrição e protocolo.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado, em visita presencial. Indicação: resistência ou impossibilidade de irrigação/administração

em sonda enteral. Não iniciar desobstrução se houver suspeita de deslocamento, exteriorização, alteração do comprimento,

tosse/dispneia durante infusão, dor intensa, sangramento, extravasamento, peritonismo ou instabilidade. Em sonda

nasoenteral, confirmar posição por método institucional validado antes de qualquer líquido; na impossibilidade, suspender

uso e encaminhar.

4. Materiais e responsabilidades

Enfermeiro: EPIs, higienização, avaliação clínica, seringa enteral ENFit 60 mL compatível, medidor de temperatura se

necessário e equipamento de avaliação presencial (esfigmomanômetro validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro).

Paciente/responsável: água apropriada ao dispositivo e condição clínica, materiais específicos e documentação do

fabricante, conforme pactuação. Nunca conectar seringa Luer a dispositivo enteral.

5. Avaliação clínica e preparação

Identificar tipo, calibre, via e localização terminal da sonda, data de inserção, método de fixação, último uso e causa provável

(dieta/medicamentos). Investigar vômitos, dor, distensão, febre, sangramento, perda de comprimento externo e sinais de

aspiração. Verificar prescrição de líquidos e restrição hídrica; conferir manual do fabricante e protocolo de confirmação de

posição.

6. Execução técnica numerada

1. Suspender imediatamente dieta e medicamentos pela sonda; comunicar ao responsável e identificar medicamentos

essenciais com horário crítico.

2. Higienizar mãos, preparar campo limpo, conferir tipo de conector e integridade externa; avaliar dobra, clamp fechado ou

compressão externa sem manipulação traumática.

3. Confirmar identificação, posição e segurança do dispositivo segundo tipo de sonda e método validado. Se posição incerta,

NÃO irrigar; encaminhar para confirmação.

4. Verificar prescrição de volume hídrico e selecionar água apropriada: jejunal ou paciente imunossuprimido geralmente

requer água estéril ou fervida e resfriada, conforme protocolo; não usar água excessivamente quente.

5. Se elegível para tentativa, conectar seringa ENFit de 60 mL e utilizar pequeno volume de água morna (aprox. 40–45 °C)

em manobra SUAVE de aspiração/irrigação, sem força, conforme protocolo e tolerância do paciente.

6. Se houver resistência, não elevar pressão; permitir tempo de contato e repetir suavemente apenas se permitido pelo

protocolo do dispositivo, monitorando desconforto, vazamento ou alteração clínica.

7. Não utilizar objetos, fio-guia, cola, sucos ácidos, refrigerantes ou improvisações. Bicarbonato e enzimas não fazem parte

da primeira linha ONEMA; considerar somente sob prescrição/protocolo especializado e avaliação de compatibilidade.

8. Se desobstruída, confirmar permeabilidade e ausência de sintomas, respeitando volume prescrito; retomar

dieta/medicação somente após checagem de segurança e posição.

9. Se persistir obstrução, suspender uso, acionar equipe prescritor/nutrição/serviço implantador para avaliação e possível

substituição em ambiente apropriado. Não substituir automaticamente no domicílio.

10. Documentar resultado, volume utilizado, tipo de água, integridade da sonda, sintomas, condutas e plano para

nutrição/hidratação/medicamentos até resolução.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Interromper diante de dor, tosse, dispneia, vômitos, distensão, sangramento, vazamento, mudança de posição ou resistência

persistente. Encaminhamento urgente se risco de aspiração, desidratação, perda de medicamentos essenciais, sinais de

abdome agudo ou instabilidade; SAMU 192 quando emergência. Não irrigar sonda nasoenteral sem confirmação segura de

posicionamento.

8. Cuidados posteriores e orientação

Reforçar lavagens prescritas antes/depois da dieta e entre medicamentos, sem volumes universais em restrição

hídrica/pediatria. Evitar misturar medicamentos; confirmar formulações adequadas com prescritor/farmacêutico. Orientar

sinais de deslocamento e quando suspender a administração.

9. Registros Carteira Digital ONEMA

Registrar tipo/modelo/rota, indicação, avaliação de posição, condição clínica, materiais, volumes, temperatura aproximada,

técnica e número de tentativas, tolerância, resultado, comunicação ao prescritor/RT, encaminhamento e plano, identificação

e assinatura do enfermeiro.

10. Referências técnicas rastreáveis

NHS SPS 2025/2026 para irrigação com água morna, ENFit, seleção de água e avaliação de substituição; protocolo Royal

Cornwall 2026 para segurança da sonda nasogástrica. Há diferenças entre instituições para métodos adicionais; ONEMA

adota abordagem conservadora neste protocolo.

FONTES CONSULTADAS E LINKS

NHS Specialist Pharmacy Service, 2025. Preventing and managing enteral feeding tube blockages —

https://sps.nhs.uk/articles/preventing-and-managing-enteral-feeding-tube-blockages/

NHS Specialist Pharmacy Service, atualização 2026. Administering a medicine through an enteral feeding tube —

https://sps.nhs.uk/articles/administering-a-medicine-through-an-enteral-feeding-tube/

Royal Cornwall Hospitals NHS Trust. Ongoing Care and Management of Fine Bore Nasogastric Feeding Tubes, 2026 — http

s://doclibrary-rcht.cornwall.nhs.uk/DocumentsLibrary/RoyalCornwallHospitalsTrust/Clinical/Dietetics/OngoingCareandMa nage

mentofFineBoreNasogastricFeedingTubesNGinAdultsPolicy.pdf